

Profilaktyka *nawrotów*

Trzy mechanizmy nawrotu, plan działania na powrót strachu, normalizacja okazjonalnego lęku. Karta do zatrzymania po zakończeniu terapii.

CZAS PRACY: 15 min **FAZA:** ostatnie 2–3 sesje + po terapii

ŹRÓDŁO: Bouton (2002); Craske i wsp. (2014); Rachman (1989)

JAK UŻYWAĆ

Terapia fobii to **nie jednorazowe usunięcie lęku**, ale budowanie i podtrzymywanie nowej sieci skojarzeń. Nowe skojarzenie („obiekt jest bezpieczny”) podlega tym samym prawom co wygaszanie warunkowe — może osłabnąć w czasie, w nowych kontekstach, po stresie. Profilaktyka nawrotów to *plan działania* na te sytuacje.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Statystyki są jasne: 20–30% pacjentów doświadcza nawrotu fobii w ciągu 1–2 lat po terapii. **Większość nawrotów jest jednak odwracalna**, jeśli pacjent ma plan działania i nie traktuje powracającego lęku jako „znowu jestem chory/-a”. Craske i wsp. (2014): nawrót nie oznacza niepowodzenia terapii — oznacza, że stare skojarzenie w pamięci ożyło i wymaga przypomnienia, że nowe nadal jest aktualne. Plan profilaktyki obejmuje cztery elementy: **okazjonalną ekspozycję** (co 2–4 tygodnie), **różnorodność kontekstów** (pogłębione wygaszanie, ang. *deepened extinction*), **rozpoznanie wczesnych sygnałów** oraz **protokół działania** na pierwsze symptomy powrotu unikania.

01 Trzy mechanizmy nawrotu — co się dzieje i kiedy

1 · SPONTANICZNY POWRÓT

Lęk wraca po prostu z upływem czasu, bez nowego doświadczenia. Pamięć starego skojarzenia odzyskuje siłę. Najczęstszy w pierwszych 6–12 miesiącach.

2 · ODNOWIENIE KONTEKSTOWE

Lęk wraca w nowym miejscu — w gabinecie spokój, w domu strach. Nowe skojarzenie jest kontekstowo zależne; przy zmianie środowiska stare skojarzenie ma „przewagę”.

3 · PRZYWRÓCENIE

Lęk wraca po stresującym doświadczeniu, nawet niezwiązanym z fobią. Rozwód, choroba, śmierć bliskiej osoby. Stres ożywia stare skojarzenie w pamięci.

02 Cztery filary planu profilaktyki

1 · OKAZJONALNA EKSPOZYCJA

Co 2–4 tygodnie — krótki, świadomy kontakt z bodźcem fobii. 5–10 minut wystarczy, żeby utrzymać nowe skojarzenie w przewodzie.

2 · RÓŻNORODNOŚĆ KONTEKSTÓW

Nie tylko w jednym miejscu — różne lokalizacje, pory dnia, stany emocjonalne. Pogłębione wygaszanie (*deepened extinction*) chroni przed odnowieniem.

3 · SESJE PRZYPOMINAJĄCE (BOOSTER)

1 sesja z terapeutą po 3, 6 i 12 miesiącach od zakończenia terapii. Krótka, ale konkretna — sprawdzasz, czego unikasz, planujesz odświeżenie.

4 · PLAN NA POWRÓT STRACHU

Wczesne sygnały + konkretny protokół działania. Im wcześniej zareagujesz, tym mniej pracy potrzeba na odzyskanie postępu.

03 Mój plan profilaktyki — wypełnij na ostatnich sesjach

MOJA OKAZJONALNA EKSPOZYCJA — CO KONKRETNIE I JAK CZĘSTO

TRZY KONTEKSTY, W KTÓRYCH CHCĘ UTRZYMAĆ EKSPOZYCJĘ

WCZESNE SYGNAŁY NAWROTU — CO U MNIE WSKAZUJE, ŻE UNIKANIE WRACA

04 Protokół na pierwsze objawy — co robię i kiedy

ETAP	SYTUACJA	CO ROBIĘ	KIEDY ZWRACAM SIĘ O POMOC
1 · <i>Sygnał</i>	Zauważam, że zacząłem/-am unikać sytuacji, w której wcześniej radziłem/-am sobie spokojnie.	Zwracam uwagę. Nie panikuję. Notuję, kiedy zauważyłem/-am po raz pierwszy.	Jeszcze nie — sam/-a sobie poradzę.
2 · <i>Reakcja w tygodniu</i>	Lęk w sytuacji, której wcześniej nie unikałem/-am. Wracają katastroficzne myśli.	Świadoma, krótka ekspozycja (10–15 min). Zapis oczekiwania i rzeczywistości. Powtarzam 3–4 razy w tygodniu.	Jeszcze nie, jeśli sam plan działa.
3 · <i>Po 2 tygodniach</i>	Mimo ekspozycji unikanie się utrzymuje. Lęk nie spada. Pojawiają się zachowania zabezpieczające.	Kontakt z terapeutą — 1–2 sesje przypominające. Restrukturyzacja planu, sprawdzenie pułapek.	Tak — umów sesję.

Klucz: Okazjonalny lęk po terapii to nie nawrót. Nawrót to powrót **unikania** i ograniczenia życia. Lęk sam w sobie jest normalną reakcją mózgu — może się pojawiać przez całe życie, podobnie jak złość czy smutek. Najsilniejszym czynnikiem ochronnym jest **brak unikania**: tak długo, jak nadal wchodzisz w kontakt z bodźcem (nawet rzadziej), nowe skojarzenie pozostaje aktywne.